

CONSENTIMIENTO INFORMADO

MEDIASTINOSCOPIA CERVICAL

Diagnóstica y/o de estadificación ganglionar mediastínica

Apellido y Nombre	[Apellido y Nombre del paciente]		
DNI	[DNI]	Fecha de nacimiento	[_/_/_]
Edad	[Edad]	Sexo	[Sexo]
Domicilio	[Domicilio completo]		
Obra Social	[Obra Social]	Nº de afiliado	[Nº Afiliado]
Institución / Sanatorio	[Nombre del Sanatorio]	Fecha del acto	[_/_/_]
Médico interviniente	Dr. Pablo Maynard — Cirujano Torácico UBA — M.N. 121828 / M.P. 232938		

1. DIAGNÓSTICO

[Completar diagnóstico específico del paciente — ej.: adenopatías mediastínicas a estadificar en cáncer de pulmón / masa mediastínica a estudio / sarcoidosis a confirmar, etc.]

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Bajo anestesia general, se realiza una pequeña incisión en la base del cuello, por encima del esternón. A través de ella se introduce el mediastinoscopio, con el que se accede al espacio pretraqueal para explorar y tomar biopsias de los ganglios linfáticos mediastínicos (estaciones paratraqueales, subcarinal, entre otras) mediante disección roma bajo visión directa.

3. OBJETIVO Y BENEFICIOS ESPERADOS

Obtener material histológico y/o citológico de los ganglios mediastínicos para diagnóstico y/o estadificación de enfermedad neoplásica pulmonar u otra patología mediastínica, información que resulta determinante para definir la conducta terapéutica (quirúrgica, oncológica o expectante) más adecuada.

4. RIESGOS Y COMPLICACIONES POSIBLES

4.1 Riesgos generales de la anestesia

- Reacciones alérgicas a fármacos anestésicos, complicaciones cardiovasculares o respiratorias, y muy infrecuentemente riesgo de vida vinculado al acto anestésico.

4.2 Riesgos específicos del procedimiento

- Sangrado, en general leve y autolimitado.
- Sangrado masivo por lesión de grandes vasos mediastínicos (tronco arterial braquiocefálico/arteria innominada, cayado aórtico, arteria pulmonar, vena cava superior, vena ácigos): complicación infrecuente pero potencialmente grave, que puede requerir esternotomía o toracotomía de urgencia para su control, transfusión masiva de hemoderivados, y que en casos excepcionales puede resultar en la muerte del paciente.
- Lesión del nervio laríngeo recurrente, con mayor frecuencia el izquierdo por su trayecto mediastínico más largo, que puede provocar:

- Parálisis o paresia de la cuerda vocal del lado afectado.
- Disfonía (voz ronca, débil o "soplada"), habitualmente transitoria pero que puede ser permanente.
- Dificultad para toser en forma efectiva, con mayor riesgo de retención de secreciones.
- Riesgo de broncoaspiración por alteración del mecanismo de cierre glótico.
- En el excepcional caso de compromiso bilateral, obstrucción de la vía aérea superior con eventual necesidad de traqueostomía.
- Lesión traqueal o bronquial.
- Neumotórax.
- Neumomediastino y/o enfisema subcutáneo cervical/torácico.
- Lesión esofágica (infrecuente).
- Lesión del conducto torácico con quilotórax (infrecuente, más asociada a la disección del lado izquierdo).
- Embolia gaseosa (muy infrecuente).
- Infección de la herida cervical y/o mediastinitis (rara).
- Accidente cerebrovascular, en caso excepcional de lesión del tronco braquiocefálico que comprometa el flujo cerebral.
- Resultado no diagnóstico (biopsia insuficiente o no representativa), que puede requerir un procedimiento diagnóstico adicional.
- Mortalidad del procedimiento: muy baja, reportada en la bibliografía en torno al 0,08-0,3%, vinculada casi siempre a sangrado vascular mayor.

5. ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS

Punción-aspiración transbronquial guiada por ecografía endobronquial (EBUS-TBNA); punción guiada por ecografía transesofágica (EUS-FNA); biopsia percutánea guiada por imágenes según localización de la lesión; mediastinotomía anterior (técnica de Chamberlain); videotoracoscopia (VATS) diagnóstica; estadificación exclusivamente por PET-CT sin confirmación histológica (con menor rendimiento diagnóstico y no recomendada cuando se requiere tejido).

6. CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

Falta de diagnóstico histológico y/o de estadificación adecuada de la enfermedad de base, lo que puede conducir a decisiones terapéuticas basadas en estudios de menor rendimiento diagnóstico, con riesgo de sub- o sobretratamiento (por ejemplo, indicar cirugía en un paciente con enfermedad ganglionar no resecable, o negar cirugía curativa a un paciente que sí sería candidato).

7. DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que el Dr. Pablo Maynard y su equipo me han explicado, en lenguaje claro y comprensible, mi diagnóstico, el procedimiento propuesto, sus beneficios esperados, los riesgos y complicaciones posibles —generales y específicos—, las alternativas terapéuticas disponibles y las consecuencias previsibles de no realizar el procedimiento. He tenido la oportunidad de formular todas las preguntas que consideré necesarias y las mismas fueron respondidas de manera satisfactoria. Comprendo que la Medicina no es una ciencia exacta y que no se me ha garantizado un resultado determinado. En consecuencia, presto mi consentimiento libre, voluntario e informado para la realización del procedimiento descrito en el presente documento, incluyendo los procedimientos anestésicos necesarios para su realización.

8. AUTORIZACIONES ADICIONALES

- ☐ Autorizo la ampliación o modificación del procedimiento planificado si, durante el acto operatorio, surgieran hallazgos imprevistos que a criterio del equipo actuante hagan necesario o conveniente dicho cambio para preservar mi salud o mi vida.
- ☐ Autorizo la administración de hemoderivados (transfusión) en caso de ser necesario.
- ☐ Autorizo el envío de las muestras/tejidos obtenidos a estudio anatomopatológico y, de corresponder, a estudios moleculares/genéticos complementarios.
- ☐ Autorizo la toma de fotografías/videos del procedimiento con fines académicos y/o de docencia, resguardando mi identidad (Art. 8°, Ley 26.529). En caso de no autorizar, tildar la opción correspondiente:
- ☐ No autorizo la toma de fotografías/videos con fines académicos.

9. REVOCABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento previo a la realización del procedimiento, sin necesidad de expresar causa y sin que ello genere consecuencia negativa alguna sobre mi atención médica posterior (Art. 10, Ley 26.529).

10. FIRMAS

Firma: _____ PACIENTE — Nombre: _____ DNI: _____	
Firma: _____ REPRESENTANTE LEGAL (si corresponde) — Nombre: _____ DNI: _____ Vínculo: _____	
Firma y sello: _____ MÉDICO INTERVINIENTE	Firma: _____ TESTIGO (opcional) — Nombre: _____ DNI: _____